ONEMA-POP-015 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

1

ONEMA-POP-015 — Conciliação Medicamentosa e Prevenção de

Discrepâncias no Atendimento ONEMA

1. Identificação institucional, código, título, versão e RT

ONEMA SAÚDE | ONEMA-POP-015 | Conciliação Medicamentosa e Prevenção de Discrepâncias no Atendimento

2. Objetivo e abrangência

Identificar e resolver discrepâncias entre medicamentos prescritos, dispensados e efetivamente utilizados.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado, com treinamento e atuação dentro das competências profissionais. Transições de cuidado, alta hospitalar, primeira visita e alterações terapêuticas; enfermeiro não substitui prescritor em mudanças de dose.

4. Materiais, equipamentos e responsável pelo fornecimento

Paciente: receitas, caixas, organizadores e sumários de alta; enfermeiro: formulário de conciliação, acesso autorizado à Carteira Digital e canais para prescritor/farmácia. Fornecimento pactuado no pedido e confirmado antes da visita.

5. Avaliação clínica e preparação

Reunir histórico de medicamentos prescritos e de uso real, incluindo OTC, fitoterápicos, suplementos, alergias, doses, horários, vias e adesão.

6. Execução técnica numerada e verificável

1. Confirmar paciente e finalidade da conciliação; obter consentimento e fontes documentais.

2. Construir lista de melhor história medicamentosa possível por entrevista, embalagens e documentos, registrando fontes

e incertezas.

3. Comparar a lista com prescrições atuais, sumário de alta e orientações recentes.

4. Marcar cada divergência: omissão, duplicidade, dose, via, frequência, duração, interação ou medicamento sem

indicação clara.

5. Identificar sinais clínicos relacionados a erro ou evento adverso e priorizar risco imediato, sobretudo insulina,

anticoagulantes e sedativos.

6. Distinguir alteração intencional documentada de discrepância não explicada; não corrigir prescrição por conta própria.

7. Comunicar divergências prioritárias ao prescritor/farmacêutico, documentando contato, decisão e prazo de resolução.

8. Atualizar lista conciliada somente após confirmação da conduta e orientar paciente/cuidador por técnica de retorno

demonstrado.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Duplicidade de alto risco com sintomas, suspeita de superdose, hipoglicemia, sangramento ou sedação importante:

interromper rotina e providenciar avaliação urgente.

8. Cuidados posteriores e orientações

Fornecer lista única atualizada com data, responsável e pendências explícitas; solicitar que seja apresentada em todos os

atendimentos.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Identificação e consentimento; avaliação inicial e sinais vitais quando indicados; descrição objetiva, classificação/medidas,

intervenção, insumos, resposta, intercorrências, orientações, comunicação e plano de seguimento; assinatura profissional

e trilha de auditoria.

10. Referências técnicas específicas e rastreáveis

2

AHRQ — MATCH Toolkit for Medication Reconciliation —

https://www.ahrq.gov/patient-safety/settings/hospital/match/index.html

WHO — Medication Without Harm — https://www.who.int/initiatives/medication-without-harm